游戏介入智障儿童言语康复个案研究

李俊强

（东莞市康复实验学校 广东东莞 523129）

摘 要：言语和语言障碍是智障学生发育过程中的普遍性障碍。在评估的基础上，运用游戏介入智障儿童言语康复训练，可以明显提高康复训练效果。文章以一名唐氏综合征学生的言语康复训练为例，介绍了游戏介入言语康复训练的过程和方法，并且进行了20周的康复训练实践。分析该个案训练前后评估结果，以及对家长和教师的访谈发现，训练效果较好，该个案言语发育迟缓和构音障碍等情况明显改善。

关键词：智力障碍；游戏；言语康复

中图分类号：G764 **文献标识码：**A **文章编号：**2095-0438(2020)10-0058-04

目前，我国培智学校学生多为中重度智力障碍、脑瘫、自闭症等，他们往往同时具有智力障碍、言语和语言障碍、认知障碍和运动障碍中的两种或两种以上的障碍，其中言语和语言障碍是大多数学生在发育过程中普遍具有的。[1]如何促进学生语言能力发展，提高学生沟通交流能力，一直是培智学校关注的重点问题。传统的言语和语言康复，主要以课堂教学（集体课或个训课）的形式开展，重复、枯燥的训练过程不能调动特殊学生的积极性，他们往往会拒绝或排斥训练。

游戏，作为生活的一个缩影，可以让儿童在情景和参与中获得替代性学习，在互动中提升自我概念和自我效能感，表现出高涨的兴趣和高效的结果。[2]Bundy提出需要观察活动的游戏性，并且指出："活动只有具有游戏性才会促进儿童的自发性和内在的欲望， 使儿童获得对活动的主动权和了解环境的感觉，从而达到游戏的作用。"[3]在特殊儿童康复训练中融入游戏的方法，可以达到其它干预方案所没有的效率和效果。

因此，我们在深入研究学情和言语康复目标的基础上，运用游戏的方法对智障儿童开展言语康复训练，并取得较好的效果。下面以对小唐的训练过程为例进行介绍。

一、案例基本情况

（一）基本情况。小唐，女，7岁，为单亲家庭，家庭主要成员为妈妈、外婆，妈妈为个体户，每天忙于生计，由外婆照顾其日常生活。外婆主要讲粤语，普通话水平极差。小唐于3岁时被诊断为唐氏综合征，IQ值为65，存在言语障碍，无法通过言语与人沟通。她的性格胆小、畏生；曾先后在2所机构进行康复训练，效果不明显。现就读于特殊学校智

收稿日期：2020-06-01

作者简介：李俊强（1977—），男，广东东莞人，东莞市康复实验学校语文小学高级教师（副高级），研究方向：特殊教育管理、特殊学生教育。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

障2年级。

其基本能力如下：

感知觉能力：视力正常，听力较好，喜欢听节奏感强的音乐，乐感较好。

认知能力：认知能力一般，记得慢、忘得快，理解能力较差。

语言能力：语言较差，只能发单个字或单词，声音小，发音不准；能理解指令，但是对于较为复杂的语句理解不准确。

社交能力：胆小，不愿意与别人交往。

动作能力：粗大动作和精细动作均较好；身体协调性较好，平衡性、柔韧性均较好，舞蹈动作优美。

自理能力：生活自理能力较好，能独立完成穿衣服、用餐、喝水等；能完成扫地、洗碗等家务。

（二）评估情况。结合医生诊断，并经过日常观察和访谈，小唐的言语障碍表现明显。采用我校修订的《构音障碍检查表》和《语言发育迟缓检查表》对其进行初步评估。评估结果如下：

1.呼吸方式正常，能正确运用腹式呼吸；呼吸支持不足，声音小；

2.经检查小唐下颌、唇、舌等构音器官运动情况，其舌部较大，外伸减少，灵活度差，唇力度减低，咂唇力量减低，下颌张开范围不足，咀嚼范围减少，其余构音器官运动无异常，发音声音小，清晰度尚可；

3.单词检查，p、g、k发音不准，其余尚可；

4.词理解和词表达能力落后于正常儿童，单词理解方面，表示大小、颜色的词语理解不准；词语表达方面以单词为主，名词表达尚可，动词表达能力一般；2词句理解和表达均存在困难。

综上，小唐诊断为语言发育迟缓，语言理解和表达能力处于阶段3-2；构音障碍。

二、训练方案

根据小唐乐感较好、节奏感较强、喜欢跳舞等优势，以及其呼吸支持不足、语言发育迟缓等问题，主要通过康复集体课与个训课相结合、学科教学与言语康复相结合的方式，对其进行言语康复；运用游戏法介入训练过程，使小唐在玩中学、玩中练，激发其训练兴趣，提高训练的积极性。共进行20周的训练。

（一）训练目标及内容。

1.呼吸训练及唱音训练。训练呼吸的支持能力，增强肺活量；通过训练大声和小声地说韵母，练习响度控制能力通过长时间和短时间说韵母练习呼吸能力，通过大声、小声、长声、短声交替说韵母，练习呼吸与发声的协调能力。

2. 语言理解能力训练。通过对话、情景表演等练习，训练语言表达和语言理解能力，增强用语言与人沟通交流的能力。

3.言语表达能力训练。以小唐容易混淆的b/p、g/k组合目标词，每句话1个目标词、1—2个陪衬词组成2词句进行训练，由浅及深、由简单到复杂，进行言语表达能力训练。

（二）训练用具、研究工具及游戏准备。按照训练及研究的需要，准备相应的用具和工具辅助完成相关活动。

1.训练用具：准备按摩球（器）、Rood刷、冰块、按摩刷、压舌板等面部、舌按摩和刺激的用具；各类长短形状不一的吸管、吹气笛套装等呼吸训练用具；各类图卡、词卡、玩具等游戏用具；紫菜、饼干、各类果干、酸奶等食品，既作为康复用具，又作为强化物。

2.研究工具：使用《构音障碍检查表》和《语言发育迟缓检查表》，分别进行基线期、干预期和追踪期的评估；设置《言语发展记录表》，记录每次训练过程中训练对象言语理解和表达的词语数量、句子长度和发音准确度。

3.游戏准备：游戏的类型包括探索性游戏、社交性游戏、运动性游戏、假想性游戏、操作性游戏和解决问题游戏等。在研究之前，我们准备了80个游戏活动，包括：呼吸训练游戏（例如：《扫树叶》《乒乒乓乓运球咯》等），用以提高学生呼吸支持能力、增加肺活量、增强呼吸肌肉群的力量等；情景表演游戏（例如：《老山羊请客》《小猴子下山》等），通过情景对话和表演来训练学生的语言理解和语言表达能力；口部运动游戏活动（含下颌运动游戏、唇部运动游戏、舌部运动游戏等），训练学生的口部肌肉运动及感知觉、促进正常的口部运动模式；构音运动游戏活动（含构音器官运动游戏和b/p、g/k发音的游戏），主要训练学生构音器官和发音的准确性。

（三）训练方法及过程设计。按照课程时间安排，每天训练1次，每次训练70分钟（中间休息10分钟），训练过程包括言语放松操、语言康复活动和语言游戏活动三个环节。

1.言语放松操：按照训练目标和内容，训练前选择口腔按摩操、口肌按摩操、唇部运动操、下颌运动操、舌部运动操

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

等言语放松操活动(每次选其一或二)进行放松活动,放松呼吸系统、发音系统及构音系统的相关肌肉群,调动兴趣、促进各器官的协调。

2.语言康复活动:结合学生生活设置情境,开展对话和表演游戏,提高学生语言理解和语言表达的能力。例如:开展《小蝌蚪找妈妈》《老山羊请客》《小猴子下山》等情景游戏活动,请小唐戴上相应表演对象的头饰,按照故事发展的情景进行游戏表演,在表演的过程中实现有效沟通。

3.言语康复游戏:拓展言语康复训练内容,以教师为主导,按照每次言语康复训练的目标,组织开展相应的游戏活动,使学生在游戏中进行言语康复训练,有针对性训练小唐呼吸控制能力、构音器官运动能力和句子表达能力。

三、训练效果分析

(一)分析评估结果。

1.语言康复训练实施的前后,我们使用《语言发育迟缓检查表》对小唐进行理解和表达能力评估,并将小唐语言康复训练前后的言语理解和表达情况进行统计,统计结果分别如表1所示:

表1　小唐语言发育迟缓检查情况

周次	阶段3-2					阶段4-1(2词句)				阶段4-2(3句)	
	颜色	大小	动词	身体部位	事物名称	颜色+事物	大小+事物	动物主+动作	动作+对象	大小+颜色+事物	动物主+动作+对象
1	−	−	+	+	+	−	−	−	−		
21	+	+	+	+	+	±	+	±	+	−	−

记录与分析:
第1周检查,小唐对实物理解较好,图片理解情况一般,特别是颜色、大小等不理解;表达方面,能根据指向说出动作、身体部位和事物名称,对大小、颜色表达不准确;言语模仿和手势模仿尚可,交流态度一般,声音小、断断续续,主动性语言较少,配合情况尚可。
第21周检查,小唐对实物和图片理解能力较好,对2词句的理解较好,对3词句(例如:大黄帽子、小红鞋等理解存在困难);表达方面,能用言语较正确表达2词句,不能通过看图说出3词句;言语模仿和手势模仿均较好,交流态度较好,对比第1周,主动性语言明显增多,配合情况较好。

根据表1,训练前小唐语言理解和表达能力处于阶段3-2,训练后其语言理解和表达能力达到阶段4-1。这说明,运用游戏介入言语康复训练,经过20周的训练是有效的。

2.用《构音障碍检查表》对小唐训练前后分别进行构音检查,检查结果如表2-3所示:

表2　小唐构音检查结果分析(第1周)

错音	条件	错误方式	一贯性		被刺激性		类似运动	错误类型	备注
			发声方法	错法	音节	音			
P	词头	b	+	−	−	−	不会鼓腮;吐气一般	置换	
g	词头	k	+	−	+	+	不能舌根上举	置换	
k	词头	g	+	−	−	+		置换	

结果分析:
构音器官检查,小唐呼吸能用胸腹呼吸,呼吸次数27次/分钟,能快速呼气;唇力度减低、咂唇力量减低,舌头较大,活动不充分、笨拙外伸减少,下颌张开范围不足,咀嚼范围减少。
单词检查:双唇音(p)和舌根音(g/k)词头容易混淆(替换),其余音尚可。
音节复述检查:p音刺激反应不明显;k音刺激反应不明显、g音节刺激反应不明显。
文章检查:读句子连贯性差,断断续续、无法连词成句;p、g/k词头发音不准。
构音类似运动检查:不会鼓腮,叩腮、吐气一般,舌根不能上举,其余尚可。

表3　训练前小唐构音检查结果分析(第21周)

错音	条件	错误方式	一贯性		被刺激性		类似运动	错误类型	备注
			发声方法	错法	音节	音			
P	词头	b	−	−	+	+	能鼓腮、吐气	置换	

结果分析:
对比第1周检查结果,构音器官尚可,呼吸次数22次/分钟;唇力度正常,舌头较大,活动情况有所改善;g/k音已能准确发音;p音偶尔发音不准,以b音替换;音节复述刺激反应明显;读句子连贯性有所改善,能连续正确读出3词句,声音有所增大。

通过表2、表3可以看出,游戏介入小唐的言语康复训练,对其构音障碍的矫正具有明显效果。

(二)教师和家长访谈。20周的训练结束后,我们分别对小唐的科任教师张老师、生活老师麦老师及小唐的父母进行了访谈,了解训练的效果。张老师认为,小唐的语言理解和表达能力均有所提升,上课回答问题的积极性增加,声音较以前响亮,这对于其语文学科的学习成绩有很大的促进;麦老师认为,小唐的主动语言比以前多了,与老师、同学之间的言语沟通明显增多,言语清晰度也明显增强;小唐的父母对小唐的进步非常满意,他们说小唐的语言表达能力进步很大,和家长的言语交流数量增加,经常会主动用言语表达自己的需要,性格也比以前乐观了。

四、反思和体会

(一)运用游戏介入智障儿童言语康复训练,起到了事半功倍的效果。由于身心发展障碍的影响,智障儿童从小就缺少玩伴,也缺乏自主参与游戏的能力和技巧,享受不到游戏带来的心理满足和愉悦感,却常常面对的是机构中相对枯燥

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

而被动的康复训练，康复效果大打折扣[4]。运用游戏的方法对智障儿童进行言语康复训练，将枯燥乏味甚至于有些痛楚的训练过程通过游戏的方式呈现出来，可以充分调动学生的训练积极性和主动性，激发学习兴趣，大大提高了训练的效果。

（二）精准的评估是智障儿童言语康复训练的基础。儿童言语障碍（或发育迟缓）的原因各有不同，不同原因造成的言语障碍，训练的目标和方法也迥异。 因此，精准的评估是智障儿童言语康复训练的基础。这要求治疗师（教师）必须熟练掌握言语专业知识和评估工具，训练前实施全面、专业、精准的评估，为选择训练方法和内容奠定基础。

（三）一致性和连贯性的康复训练实施非常重要。我们每天的个训课或集体课训练时间有限，各科任教师（含生活老师）和家长的协助参与就尤为重要。在训练前，邀请科任教师和家长参与，组成康复训练小组，在对评估报告进行充分研判的基础上统一训练的目标，并共同参与训练。在课余时间，各小组成员将训练与学生的日常生活结合起来，让学生时时、事事、处处可以进行训练（例如：生活情境游戏对话等），从而不断夯实训练效果。

参考文献：

[1]白银婷.培智学校低学段语言康复课程开发的研究[D].上海：华东师范大学，2010.

[2]周念丽.特殊儿童的游戏治疗[M].北京：北京大学出版社，2011:65.

[3]魏国荣.游戏与残疾儿童康复[J].社会福利，2009(5):42.

[4]王彤梅.运用传统游戏对特殊儿童进行康复策略的研究[J].山西广播电视大学学报，2017(2):24

[责任编辑　靳开宇]

A Case Study on the Intervention of Games in Speech Rehabilitation of Mentally Retarded Children

Li Junqiang

(Dongguan Rehabilitation Experimental School, Dongguan, Guangdong 523129)

Abstract: Speech and language barriers are common barriers in the development of students with intellectual disabilities. On the basis of evaluation, using games to intervene in speech rehabilitation training for children with mental disabilities can significantly improve the effect of rehabilitation training. The article takes the speech rehabilitation training of a student with Down syndrome as an example, introduces the process and methods of game intervention speech rehabilitation training, and has carried out rehabilitation training for 20 weeks. Through analyzing the evaluation results before and after the training of the case, as well as the interviews with parents and teachers, it found that the training effect was better, and the speech development delay and dysarthria of the case were significantly improved.

Key words: mental retardation; games; speech rehabilitation

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net